

CUALQUIERA PUEDE SALVAR UNA VIDA



Taller de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador externo automatizado (DEA).

Guión completo del ponente · 15 minutos de explicación + 20-30 minutos de práctica.

GUIÓN Y TIEMPOS

01	Introducción — la pregunta y los datos	2-3 min
02	¿Qué es una parada cardiaca?	3 min
03	Cadena de supervivencia	3 min
04	Presentación del DEA	5 min
05	Demostración completa — 11 pasos	10 min
06	Mitos y miedos	5 min
07	Demostración con voluntarios	10-20 min
08	Cierre — las tres cosas	2 min

FORMATO RECOMENDADO

Taller participativo: **15 minutos de explicación seguidos de 20-30 minutos de práctica.** Es el formato que deja más aprendizaje y, sobre todo, más confianza para que la gente se anime a actuar.

EMPEZAR CON UNA PREGUNTA

«¿Sabéis cuál es la diferencia entre una persona que sobrevive a una parada cardiaca y otra que no?»

- Dejar unos segundos de silencio. Que respondan.

Después explicar:

Miles

de paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias cada año en España.

-10 %

de probabilidad de supervivencia por cada minuto que pasa sin actuar.

Minutos

La ambulancia puede tardar varios minutos en llegar.

Testigos

Los primeros en salvar una vida casi siempre son los testigos.

MENSAJE CLAVE

No hace falta ser sanitario para salvar una vida.

¿QUÉ ES UNA PARADA CARDIACA?

- Explicar de forma sencilla. Sin tecnicismos.

«No es un infarto.»

Un infarto **puede** producir una parada. Pero una parada es otra cosa: es cuando...

EL CORAZÓN DEJA DE BOMBLEAR

No llega sangre al cerebro. Sin sangre, cada segundo cuenta.

LA PERSONA ESTÁ INCONSCIENTE

Se ha desplomado. No responde a la voz ni al estímulo.

NO RESPIRA CON NORMALIDAD

O no respira, o hace **boqueadas**: jadeos aislados, ruidosos, que engañan.

HACER ÉNFASIS

Si dudas... actúa como si fuera una parada.

Comprimir a quien no lo necesitaba causa un daño mínimo. No comprimir a quien lo necesitaba es la muerte.

CUATRO ESLABONES

► Se pueden dibujar en una pizarra según se van nombrando.

01

**RECONOCER
LA PARADA**

02

**LLAMAR
AL 112**

03

**EMPEZAR
LA RCP**

04

**USAR EL DEA
CUANTO ANTES**

«Ninguno funciona bien sin el anterior.»

Es una cadena de verdad: si falta un eslabón, se rompe entera. Da igual lo rápida que sea la ambulancia si nadie ha reconocido la parada. Y da igual que llegue el desfibrilador si nadie ha comprimido mientras tanto.

Y el primer eslabón siempre lo pone un testigo. Es decir: cualquiera de los que estáis aquí.

SACAR EL EQUIPO

- ▶ Sacar el DEA delante de todos y enseñarlo en alto.

«¿Da miedo?»

- ▶ La mayoría responderá que sí.

ENTONCES DECIRLES

«En cinco minutos vais a perder ese miedo.»

A partir de aquí el aparato circula. Que lo toquen, que lo abran, que lo cierren. El miedo se va cuando lo has tenido en las manos.



Primedic AED cerrado · indicador de estado «OK»

ENSEÑAR, UNA POR UNA

- 1 La pantalla**
Dónde mira uno para saber qué está pasando.
- 2 El indicador OK**
Se autocomprueba solo. Si pone OK, está listo para usarse.
- 3 El botón de encendido**
Verde. Es lo primero que se pulsa y lo único que hay que recordar.
- 4 El botón de descarga**
Naranja, con el rayo. Solo se pulsa cuando el aparato lo pide.
- 5 Los electrodos**
En su bolsa sellada, con el dibujo de dónde va cada uno.
- 6 El modo pediátrico**
El botón «1-8». Para niños de 1 a 8 años.

EXPLICAR

«El desfibrilador piensa por vosotros.»

Él decide cuándo analizar · cuándo descargar · y cuándo **NO** descargar. Nunca da una descarga si no está indicada.



Primedic AED abierto · pictogramas, electrodos y botonera

EL ESCENARIO

- ▶ Colocar el maniquí en el suelo, en medio, con la gente alrededor.

«Una persona cae al suelo delante de vosotros.»

«¿Qué hacemos?»

- ▶ Dejar que respondan ellos. Anotar mentalmente lo que dicen: casi siempre sale «llamar al 112» y casi nunca «comprimir».
- ▶ Después realizar la secuencia entera, paso por paso, en voz alta.

TRUCO

Hacerlo primero mal a propósito (dudar, quedarse quieto, mirar alrededor) y luego bien. El contraste se recuerda mucho mejor que la explicación.

HUECO PARA IMAGEN

Foto del maniquí de RCP en el suelo con el material del taller preparado alrededor, o de un taller anterior.

VALORACIÓN Y AVISO

1**Comprobar la seguridad**

Tráfico, cables, agua, fuego, humo. Si el sitio no es seguro para ti, no lo es para nadie.

2**Hablarle**

«**¿Se encuentra bien?**» — En voz alta, cerca del oído.

3**Estimular**

Sacudir suavemente por los hombros. Sin mover la cabeza.

4**Abrir la vía aérea**

Maniobra frente-mentón: una mano en la frente, dos dedos en la barbilla, cabeza hacia atrás.

5**Comprobar la respiración durante menos de 10 segundos**

Ver el pecho, oír, sentir el aire en la mejilla. **Aquí se explican las boqueadas:** jadeos aislados, ruidosos, como un pez fuera del agua. Parece que respira, pero no respira. Eso **es** una parada.

6**Llamar al 112**

Señalar a una persona concreta: «**Tú, el de la camisa azul: llama al 112 y vuelve a decirme que lo has hecho.**» Manos libres, teléfono en el suelo. El teleoperador guía mientras se comprime. A otra persona: «Tú, trae el desfibrilador.»

- Se puede pedir aquí un voluntario del público para que haga la llamada de verdad.

PASO 7 · COMENZAR LA RCP

Centro

del pecho. Talón de una mano, la otra encima, dedos entrelazados. Brazos rectos, hombros encima.

100-120

compresiones por minuto. El ritmo de «La Macarena» o «Stayin' Alive».

5-6 cm

de profundidad. Hay que hundir el pecho de verdad. Y dejar que suba del todo entre compresión y compresión.

HACER QUE PRACTIQUEN

Que todo el mundo dé al menos 30 compresiones en el maniquí, con el metrónomo puesto. Es el momento en el que descubren que **cansa** y que hay que apretar mucho más de lo que pensaban.

Si alguien no quiere o no sabe ventilar: **solo compresiones**. Sirve, y mucho.

HUECO PARA IMAGEN

Posición de las manos en el centro del pecho y postura del reanimador: brazos rectos, hombros sobre las manos.

PASOS 8 A 11 · ENTRA EL DEA

8 Traer el DEA, abrirlo, encenderlo, colocar los electrodos

Pecho descubierto. Un electrodo bajo la clavícula derecha, otro en el costado izquierdo bajo la axila, como indica el dibujo de la bolsa.

9 El DEA analiza

«Analizando el ritmo. No toque al paciente.» Todo el mundo separado: nadie roza a la víctima, ni la ropa, ni la manta.

10 Si recomienda descarga

«¡**Apartados todos!**» — Comprobar **visualmente**, de arriba abajo, que nadie toca. Entonces pulsar el botón naranja.

11 Volver inmediatamente a la RCP

No comprobar el pulso. No esperar. El aparato volverá a analizar solo, cada dos minutos.

MIENTRAS SE COLOCA EL DEA

NO se deja de comprimir.

Una persona pega los electrodos, la otra sigue comprimiendo.
Solo se para cuando el aparato lo pide.

HUECO PARA IMAGEN

Colocación de los electrodos sobre el maniquí,
o el dibujo de la bolsa de electrodos ampliado.

LOS MIEDOS Y LOS MITOS

- Ir haciendo las preguntas al público y dejar que contesten antes de dar la respuesta.

¿Puede electrocutarme?

NO Solo descarga si nadie toca a la víctima. Por eso se avisa y se mira antes de pulsar.

¿Puede equivocarse?

NO Analiza el ritmo cardíaco. Solo descarga si hace falta. Si no es un ritmo desfibrilable, ni siquiera carga.

¿Y si está mojado?

SECAR Y SEGUIR Secar el pecho rápidamente con una toalla. Y apartar a la persona de charcos o superficies metálicas.

¿Y si lleva un parche de medicación?

RETIRARLO Quitar el parche antes, limpiar la zona y pegar ahí el electrodo.

¿Puede matar al paciente?

NO La persona ya está en parada. Sin ayuda, el desenlace es la muerte. Solo se puede mejorar la situación.

¿Y si tiene marcapasos?

SE USA IGUAL Se nota un bultito bajo la piel. Colocar el electrodo unos centímetros separado de él.

¿Y si tiene mucho pelo?

RASURAR Solo si impide el contacto del electrodo. Rasurado rápido con la cuchilla del kit, y pegar.

¿Y si está embarazada?

SÍ Se utiliza exactamente igual. Salvar a la madre es salvar al bebé.

AHORA LO HACEN ELLOS

«Es la parte que más gusta.»

- **Que una persona haga todo**
Desde comprobar la seguridad hasta la descarga. Sin ayudas, sin interrupciones.
- **Tú solo corriges**
Y solo al final, salvo que se pare del todo. Equivocarse aquí es el objetivo, no el problema.
- **Después otra persona. Y otra.**
En diez minutos aprenderán muchísimo. Cada repetición vale más que diez explicaciones.

LO QUE SE LLEVAN

No es el procedimiento perfecto: es **haberlo hecho una vez con las manos**. Eso es lo que hace que alguien se atreva el día que pasa de verdad.

HUECO PARA IMAGEN

Gente del pueblo practicando en el maniquí, o un voluntario colocando los electrodos.

ACABAR CON ESTA IDEA

«Dentro de unos años quizá olvidéis muchas cosas de esta charla. Pero si algún día alguien cae delante de vosotros, quiero que recordéis solo tres:»

01**LLAMAR
AL 112****02****EMPEZAR A
COMPRIMIR****03****ENCENDER EL
DEFIBRILADOR**

«Eso puede marcar la diferencia entre una vida y una muerte.»

MATERIAL QUE HAY QUE LLEVAR

- ☐ El **DEA real** (el Primedic de las fotografías).
- ☐ **Electrodos de demostración**, o un juego caducado para practicar la colocación.
- ☐ Una **toalla pequeña** para simular el secado del tórax.
- ☐ Un **metrónomo** o música a 100-120 pulsaciones por minuto.
- ☐ Un **maniquí de RCP** adulto y, si es posible, también pediátrico.
- ☐ Una **cuchilla desechable** para explicar el rasurado si fuera necesario.
- ☐ **Guantes de nitrilo**, varias tallas.
- ☐ Toallitas o desinfectante para limpiar el maniquí entre voluntarios.

RECORDATORIO DE FORMATO

Explicación breve de **15 minutos** + **20-30 minutos de práctica**. Si hay que recortar, se recorta la explicación, nunca la práctica.